

보건복지부 고시 제2025-143호

「국민건강보험법」 제41조제3항 및 제4항, 「국민건강보험 요양급여 기준에 관한 규칙」 제5조제2항에 따라 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 (보건복지부 고시 제2025-129호(2025. 7. 28.))을 다음과 같이 개정·발령합니다.

2025년 8월 26일

보건복지부장관

「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 일부개정

요양급여의 적용기준 및 방법에 대한 세부사항 일부를 다음과 같이 개정한다.

Ⅱ. 약제 "[115] Methylphenidate HCl 일반형 경구제(품명: 페니드정 10밀리그램 등), [115] Methylphenidate HCl 서방형 경구제(품명: 콘서타 OROS 서방정 등), [119] Atomoxetine HCl 경구제(품명: 스트라테라캡슐 등), [119] Clonidine hydrochloride 경구제(품명: 켄베이서방정 0.1mg), [142] Guselkumab 주사제(품명: 트렘피어프리필드시린지주 등), [142] Risankizumab 주사제(품명: 스카이리치프리필드시린지주 등), [142] Tocilizumab 주사제(품명: 악템라주, 악템라피하주사 162밀리그램), [142] Ustekinumab 주사제(품명: 스텔라라 프리필드주 45mg 등), [439] Abatacept 주사제(품명: 오렌시아주 250밀리그램, 오렌시아서브큐프리필드시린지 125밀리그램), [439], Vedolizumab 주사제(품명: 킨텔레스주 등), [245] Deflazacort 경구제(품명: 켈코트정 등), [399] BDDE bridged sodium hyaluronate 60mg 주사제(품명 : 시노비안주, 하이히알원스주, 하이알원샷주), [421] Rituximab 주사제(품명: 맵테라주 등)"의 구분, 세부인정기준 및 방법의 일부를 별지 2와 같이 변경한다.

부 칙

이 고시는 2025년 9월 1일부터 시행한다.

변경대비표

[별지 2]

[115] 각성제, 흥분제, [119] 기타의 중추신경용약			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[115] Methylphenidate HCl 일반형 경구제 (품명: 페니드정 10밀리그램 등)	허가사항 범위 내에서 아래와 같이 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 수면발작 나. 주의력결핍과잉행동장애 1) ~ 3) (생 략) 4). 투여 방법 가) 단독 투여 나) 병용 투여 ○ ADHD 치료제 한 가지를 최소 1개월 이상 단독투여에도 불구하고 임상적 반응이 충분하지 않을 때 작용기전이 다른 치료제 1종을 추가할 수 있음. ※ ADHD 치료제 작용기전별 분류 (1) 정신자극제(psychostimulant):	허가사항 범위 내에서 아래와 같이 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 수면발작 나. 주의력결핍과잉행동장애 1) ~ 3) (현행과 같음) 4). 투여 방법 가) 단독 투여 나) 병용 투여 ○ 최소 1개월 이상 단독투여에도 불구하고 임상적 반응이 충분하지 않을 때 <u>비정신자극제</u> 1종을 추가할 수 있음. ※ <u>ADHD 치료제</u> (1) 정신자극제(psychostimulant):	○ 임상진료지침, 임상연구문헌, 전문가 의견 등을 참조하였을 때, 비정신자극제인 Atomoxetine과 Clonidine의 작용기전이 다른 점을 고려하여 작용기전 관련 문구 변경함

[115] 각성제, 흥분제, [119] 기타의 중추신경용약			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	methylphenidate (2) 비정신자극제(non psychostimulant): atomoxetine HCl, clonidine HCl	methylphenidate (2) 비정신자극제(non psychostimulant): atomoxetine HCl, clonidine HCl	
[115] Methylphenidate HCl 서방형 경구제 (품명: 콘서타 OROS 서방정 등)	각 약제의 허가사항 범위 내에서 아래와 같이 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약 값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가 ~ 다. (생 략) 라. 투여 방법 1) 단독 투여 2) 병용 투여 ○ ADHD 치료제 한 가지를 최소 1개월 이상 단독투여에도 불구하고 임상적 반응이 충분 하지 않을 때 작용기전이 다른 치료제 1종을 추가할 수 있음. ※ ADHD 치료제 작용기전별 분류 (1) 정 신 자 극 제 (psychostimulant): methylphenidate (2) 비정신자극제(non psychostimulant): atomoxetine HCl, clonidine HCl	각 약제의 허가사항 범위 내에서 아래와 같이 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약 값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가 ~ 다. (현행과 같음) 라. 투여 방법 1) 단독 투여 2) 병용 투여 ○ 최소 1개월 이상 단독투여에도 불구하고 임상적 반응이 충분하지 않을 때 비정신 자극제 1종을 추가할 수 있음. ※ ADHD 치료제 (1) 정 신 자 극 제 (psychostimulant): methylphenidate (2) 비정신자극제(non psychostimulant): atomoxetine HCl, clonidine HCl	

[115] 각성제, 흥분제, [119] 기타의 중추신경용약

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[119] Atomoxetine HCl 경구제 (품명: 스트라테라캡슐 등)	허가사항 범위 내에서 아래와 같이 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가 ~ 다. (생 략) 라. 투여 방법 1) 단독 투여 2) 병용 투여 ○ ADHD 치료제 한 가지를 최소 1개월 이상 단독투여에도 불구하고 임상적 반응이 충분하지 않을 때 작용기전이 다른 치료제 1종을 추가할 수 있음. ※ ADHD 치료제 작용기전별 분류 (1) 정신자극제(psychostimulant): methylphenidate (2) 비정신자극제(non psychostimulant): atomoxetine HCl, clonidine HCl	허가사항 범위 내에서 아래와 같이 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가 ~ 다. (현행과 같음) 라. 투여 방법 1) 단독 투여 2) 병용 투여 ○ 최소 1개월 이상 단독투여에도 불구하고 임상적 반응이 충분하지 않을 때 <u>정신자극제</u>를 추가할 수 있음. ※ <u>ADHD 치료제</u> (1) 정신자극제(psychostimulant): methylphenidate (2) 비정신자극제(non psychostimulant): atomoxetine HCl, clonidine HCl	
[119] Clonidine	허가사항 범위 내에서 아래와 같이 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.	허가사항 범위 내에서 아래와 같이 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.	

[115] 각성제, 흥분제, [119] 기타의 중추신경용약

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
hydrochloride 경구제(품명: 캡베이서방정 0.1mg)	- 아 래 - 가 ~ 다. (생 략) 라. 투여 방법 1) 단독 투여 2) 병용 투여 ○ ADHD 치료제 한 가지를 최소 1개월 이상 단독투여에도 불구하고 임상적 반응이 충 분하지 않을 때 작용기전이 다른 치료제 1종을 추가할 수 있음. ※ ADHD 치료제 작용기전별 분류 (1) 정 신 자극제 (psychostimulant): methylphenidate (2) 비정신자극제(non psychostimulant): atomoxetine HCl, clonidine HCl	- 아 래 - 가 ~ 다. (생 략) 라. 투여 방법 1) 단독 투여 2) 병용 투여 ○ 최소 1개월 이상 단독투여에도 불구하고 임상적 반응이 충분하지 않을 때 <u>정신자극 제</u> 를 추가할 수 있음. ※ <u>ADHD 치료제</u> (1) 정 신 자극제 (psychostimulant): methylphenidate (2) 비정신자극제(non psychostimulant): atomoxetine HCl, clonidine HCl	

※ 관련근거

- American Academy of Pediatrics(AAP) clinical practice guideline(2011)
- Joseph A. Johnston, et al, Decreased Use of clonidine following treatment with atomoxetine in children with ADHD. J Clin psychopharmacol. 2006;26(4):389-395.

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제 포함), [439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[142] Guselkumab 주사제(품명: 트렘피어프리필드 시린지주 등)	<추 가> 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가.~다. (생 략) <u><신 설></u>	1. (현행과 같음) 2. 동 약제를 사용하는 경우에는 「TNF-α inhibitor 사용시 잠복결핵 치료지침」을 따라야 함.	○ 교과서, 가이드라인, 전문가 의견 등을 참조하여 TNF-α inhibitor와 동일하게 잠복결핵 치료지 침을 따르도록 해 당 문구를 추가함.
[142] Risankizumab 주사제(품명: 스카이리치프리필 드시린지주 등)	<추 가> 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아 래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하 며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가.~나. (생 략) <u><신 설></u>	1. (현행과 같음) 2. 동 약제를 사용하는 경우에는 「TNF-α inhibitor 사용시 잠복결핵 치료지침」을 따라야 함.	

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제 포함), [439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[142] Tocilizumab 주사제(품명: 악템라주, 악템라피하주사 162밀리그램)	1.~5. (생 략) <u><신 설></u>	1.~5. (현행과 같음) 6. 동 약제를 사용하는 경우에는 「TNF-α inhibitor 사용시 잠복결핵 치료지침」을 따라야 함.	
[142] Ustekinumab 주사제(품명: 스텔라라 프리필드주 45mg 등)	<추 가> 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가.~라. (생 략) <u><신 설></u>	1. (현행과 같음) 2. 동 약제를 사용하는 경우에는 「TNF-α inhibitor 사용시 잠복결핵 치료지침」을 따라야 함.	
[439] Abatacept 주사제(품명:	1.~4. (생 략) <u><신 설></u>	1.~4. (현행과 같음) 5. 동 약제를 사용하는 경우에는 「TNF-α inhibitor 사용시 잠복결핵 치료지침」을	

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제 포함), [439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
오렌시아주 250밀리그램, 오렌시아서브큐프 리필드시린지 125밀리그램)		<u>따라야 함.</u>	
[439] Vedolizumab 주사제(품명: 킨텔레스주 등)	1.~4. (생 략) <u><신 설></u>	1.~4. (현행과 같음) 5. 동 약제를 사용하는 경우에는 「TNF- α <u>inhibitor 사용시 잠복결핵 치료지침</u> 」을 <u>따라야 함.</u>	
※ 관련근거 1. Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e, 2022 > Chapter 358: Rheumatoid Arthritis 2. Cecil Essentials of Medicine, 10e, 2022 > Chapter 79 Rheumatoid Arthritis 3. Habif's Clinical Dermatology, 7e, 2021 > Chapter 8: PSORIASIS AND OTHER PAPULOSQUAMOUS DISEASE 4. 결핵 진료지침(5판). 결핵 진료지침 개정위원회(대한결핵 및 호흡기학회, 질병관리청). 2024년 > VIII. 잠복결핵감염 > 5. 생물학적제제와 소분자억제제 관련 잠복결핵감염의 진단과 치료 5. TNF 길항제 사용시 잠복결핵 치료지침. 식품의약품안전청. 2004년 6. Fragoulis GE, et al. 2022 EULAR recommendations for screening and prophylaxis of chronic and opportunistic infections in adults with autoimmune inflammatory rheumatic diseases. Annuals of the Rheumatic Disease. 2023 Jun;82(6):742-753. 7. Kucharzik T, et al. ECCO Guidelines on the Prevention, Diagnosis, and Management of Infections in Inflammatory Bowel Disease. J Crohns Colitis. 2021 Jun 22;15(6):879-913.			

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제 포함), [439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	

[245] 부신피질호르몬제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[245] Deflazacort 경구제 (품명: 켈코트정 등)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함 - 아 래 - 가. (생 략) 나. 골다공증이 심한 이식환자 ○ 부신피질호르몬제를 장기 투여하는 환자 중에서 골다공증이 심한 환자 (검사결과 T-Score가 <추 가> 2.5 이하로 확인된 경우)에게 1차적으로 동 약제를 투여한 경우에 인정함.	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함 - 아 래 - 가. (현행과 같음) 나. 골다공증이 심한 이식환자 ○ 부신피질호르몬제를 장기 투여하는 환자 중에서 골다공증이 심한 환자 (검사결과 T-Score가 $\geq$ 2.5 이하로 확인된 경우)에게 1차적으로 동 약제를 투여한 경우에 인정함.	○ 자구 정비

[245] 부신피로증

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	다. ~ 마. (생 략)	다. ~ 마. (현행과 같음)	
※ 관련근거 · Osteoporosis, Quick Medical Diagnosis & Treatment 2025 · Ch 411. Osteoporosis, Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e. · Guidelines for preclinical evaluation and clinical trials in osteoporosis · ACR-SPR-SSR PRACTICE PARAMETER FOR THE PERFORMANCE OF QUANTITATIVE COMPUTED TOMOGRAPHY (QCT) BONE MINERAL DENSITY · 2023 ISCD Official Positions Adult · AMERICAN ASSOCIATION OF CLINICAL ENDOCRINOLOGISTS/ AMERICAN COLLEGE OF ENDOCRINOLOGY CLINICAL PRACTICE GUIDELINES FOR THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS – 2020 UPDATE · NOGG guideline 2024, Clinical guideline for the prevention and treatment of osteoporosis · IOF(International osteoporosis foundation) · Update on the Clinical Application of Quantitative Computed Tomography (QCT) in Osteoporosis · Comparison of QCT-derived and DXA-derived areal bone mineral density and T scores · 골다공증의 약물치료: 2022 update (Pharmacological treatment of osteoporosis: 2022 update) · Comparison of QCT and DXA: Osteoporosis Detection Rates in Postmenopausal Women · Improved prediction of incident vertebral fractures using opportunistic QCT compared to DXA			

[399] 따로 분류되지 않는 대사성 의약품				
현 행		개 정(안)		사유
구 분	세부인정기준 및 방법	구 분	세부인정기준 및 방법	
[399] BDDE bridged sodium hyaluronate 60mg 주사제 (품명 : 시노비안주, 하이히알원스주, 하이알원샷주 <u><추 가></u>)	(생 략)	[399] BDDE bridged sodium hyaluronate 60mg 주사제 (품명 : 시노비안주, 하이히알원스주, 하이알원샷주 등)	(현행과 같음)	○ ‘힐로드원스주’가 신규 등재 예정임에 따라, 기존 BDDE bridged sodium hyaluronate 60mg 주사제 급여기준과 동일하게 적용하도록 함. 단, 고시 구분의 품명에 ‘등’ 추가하는 것이 적절함.
※ 관련근거 <요양급여 신규등재에 따른 급여기준 변경 사항>				

[421] 항악성종양제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[421] Rituximab 주사제 (품명: 맵테라주 등)	1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. ~ 다. (생 략) 2. 허가사항 범위를 초과하여 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정함. 가. ~ 차. (생 략) <u><신 설></u>	1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. ~ 다. (현행과 같음) 2. 허가사항 범위를 초과하여 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정함. 가. ~ 차. (현행과 같음) 카. 호산구 육아종증 다발혈관염 (Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis) 1) 투여대상 가) 표준치료(고용량 스테로이드, Cyclophosphamide 등)에 불응하거나 부작용 등으로 사용할 수 없는 경우 나) 재발성 또는 주요장기를 침범하여 생명을 위협하는 중증인 경우 2) 투여방법 가) 유도요법: 1회 375mg/m²를 1주 간격	○ 교과서, 가이드라인, 임상연구문헌, 전문가 의견 등을 고려하여, ‘호산구 육아종증 다발혈관염’에 Rituximab 주사제의 급여범위를 확대함.

[421] 항악성종양제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	3. ~ 4. (생 략)	으로 4회 투여 또는 1회 1g을 2주 간격 으로 2회 투여 시 인정 나) 유지요법: 1회 500mg을 6개월마다 투여 하며, 4회까지 인정 3. ~ 4. (현행과 같음)	

※ 관련근거

- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e
- Current Diagnosis & Treatment: Rheumatology, 4e
- Fishman's Pulmonary Diseases and Disorders, 6e
- 2024 KDIGO(Kidney Disease: Improving Global Outcomes) Clinical Practice Guideline for the Management of Antineutrophil Cytoplasmic Antibody (ANCA)–Associated Vasculitis
- 2022 EULAR recommendations for the management of ANCA-associated vasculitis
- 2021 American College of Rheumatology/Vasculitis Foundation Guideline for the Management of Antineutrophil Cytoplasmic Antibody–Associated Vasculitis
- Menditto VG, et al. Rituximab for eosinophilic granulomatosis with polyangiitis: a systematic review of observational studies. Rheumatology (Oxford). 2021;60(4):1640
- Benjamin Terrier, et al. Rituximab versus Conventional Therapeutic Strategy for Remission Induction in Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis: A Double-blind, Randomized, Controlled Trial. ACR Convergence 2021
- Marta Casal M, et al. Asthma control in eosinophilic granulomatosis with polyangiitis treated with rituximab. Clin Rheumatol. 2020;39(5):1581-1590
- Teixeira V, et al. Efficacy and safety of rituximab in the treatment of eosinophilic granulomatosis with polyangiitis. RMD Open. 2019;5(1):e000905. Epub 2019 Jun 5

[421] 항악성종양제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
· Jens Thiel, et al. Rituximab as Induction Therapy in Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis Refractory to Conventional Immunosuppressive Treatment: A 36-Month Follow-Up Analysis. J Allergy Clin Immunol Pract. 2017;5(6);1566-1563 · Mohammad AJ, et al. Rituximab for the treatment of eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (Churg–Strauss). Ann Rheum Dis 2016;75:396–401			